

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Carotid Endarterectomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال باطنة الشريان السباتي

1. What do I need to know about this procedure?

This procedure removes the plaque material, or blockage in the lining of the carotid artery which goes to the brain.

It clears out of the diseased part of the main artery (carotid artery) going to the brain to reduce the risk of stroke.

The artery is exposed and clamped above and below the diseased area.

A shunt may be used at this stage to divert the blood flow.

The diseased artery and normal parts of artery are removed, the artery is sewn up and the clamps removed.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

في هذا الإجراء تتم إزالة المادة المترسبة أو الانسداد الموجود في بطانة الشريان السباتي الذي يصل إلى المخ. يؤدي هذا الإجراء إلى إزالة الجزء المريض من هذا الشريان الرئيسي (الشريان السباتي) المؤدي إلى المخ مما يقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يفتح الشريان وتوضع فيه مشابك في أعلى وأسفل الجزء المريض منه.

قد يتم في هذه المرحلة عمل تحويلة بديلة لمجرى الدم. تتم إزالة جزء الشريان المريض وجزء يسير من الجزء السليم للشريان. يتم بعد ذلك خياطة الشريان وإزالة المشابك.

2. التخدير الذي ألتقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).

- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Despite a technically perfect operation, a minor or major stroke may occur. This may cause temporary or permanent disability.
- The following problems may occur after surgery: These can be life threatening and an immediate return to surgery will occur:
 - major bleeding from the neck
 - difficulty breathing
 - stroke in 1 in 25 to 1 in 50 people.
 - vein patch rupture in 1 in 100 people.
- Major blood loss can occur during the operation. This may require a blood transfusion and further surgery.
- Cranial nerve injury. This may be permanent.
- The wound may leak blood after the operation in 1 in 20 to 1 in 50 people. Swelling and bruising may occur about the wound. This may cause airway obstruction requiring emergency treatment.
- Patch infection in 1 in 100 people. This will need treatment with antibiotics and may need further surgery.
- Hyper-perfusion syndrome. This can cause headache, fitting and haemorrhage.

عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- بالرغم من التقنية والحرفية العالية التي تم بها الإجراء، إلا أنه قد تحدث سكتة دماغية محدودة أو كبيرة. قد يسبب ذلك إعاقة مؤقتة أو دائمة.
- قد تحدث المشاكل التالية بعد العملية. هذه المشاكل قد تكون مهددة لحياة المريض وتستدعي العودة فوراً لغرفة العمليات:
 - نزيف كبير من العنق.
 - صعوبة في التنفس.
 - سكتة دماغية عند 1 من كل 25 مريض إلى 1 من كل 50 مريض.
 - تمزق رقعة الوريد عند 1 من بين كل 100 مريض.
 - قد يحدث فقدان كبير للدم أثناء العملية. قد يتطلب ذلك نقل دم للمريض وجراحة أخرى.
 - إصابة للعصب الحقي (الدماغي). قد يكون ذلك دائم.
 - قد يتسرب الدم من الجرح بعد العملية عند 1 من بين كل 20 مريض إلى 1 من بين كل 50 مريض. قد يحدث تورم وكدمة حول الجرح. قد يسبب ذلك انسداداً لمجرى الهواء مما يتطلب معالجة طارئة.
 - عدوى للرقعة المستخدمة عند 1 من بين كل 100 مريض. يتطلب ذلك المعالجة بالمضادات الحيوية، وقد يتطلب جراحة أخرى.
 - "متلازمة فرط التروية". قد تتسبب في صداع، تشنجات ونزيف مفرط.
 - قد يلتئم الجرح بطريقة غير طبيعية، وقد تزداد سماكة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red (a keloid scar) and the scar may be painful.
- There will be numbness in the neck about the wound. This will be permanent.
- There may be difficulty swallowing and talking. This may be temporary or permanent.
- There may be hoarseness of the voice after the operation. This is usually temporary.
- The block in the artery may recur in 1 in 20 people. This may require further surgery.

Notes to talk to my doctor about

الجرح ويصبح أحمر اللون (تكون ندبة الجذرة: وهي تليف للجلد يعقب الجروح) وقد تكون مؤلمة.

- سوف يكون هناك خدر في العنق حول منطقة الجرح. يكون ذلك بشكل دائم.
- قد تكون هناك صعوبة في البلع والكلام. قد يكون ذلك مؤقت أو دائم.
- قد تكون هناك بحة في الصوت بعد العملية. غالباً ما يكون ذلك بشكل مؤقت.
- قد يعود الانسداد إلى الشريان مرة أخرى عند 1 من بين كل 20 مريض. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
